内科学含诊断学 风湿系统疾病

考频（3-4 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 2　B 0　X 0

①风湿系统总论
②SLE
③类风湿关节炎（内科+外科）
④干燥综合征
⑤系统性血管炎

注意：先复习《病理学》免疫性疾病章节

核心精讲·风湿系统总论 ①

（性感认识：以题带动我讲的知识点和或教材复习）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类（见思维导图）

表 8-1-1　风湿性疾病范畴和分类

疾病分类	疾病名称
1. 弥漫性结缔组织病（最常见）	类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、系统性硬化症、炎症性肌病、系统性血管炎、重叠综合征等　红风肌酐血硬重
2. 血清阴性脊柱关节病	强直性脊柱炎、银屑病性关节炎、反应性关节炎、肠病性关节炎、未分化脊柱关节病等
3. 骨关节病	骨关节炎、关节退行性改变等　关节软骨退变
4. 遗传、代谢和内分泌疾病相关风湿性疾病	马方综合征、先天或获得性免疫缺陷病；痛风、焦磷酸钙沉积病；淀粉样变、肢端肥大症、甲减、甲旁亢相关关节病等
5. 与感染相关风湿性疾病	风湿热、莱姆病、Poncet 综合征等
6. 骨肿瘤	原发性（滑膜瘤、滑膜肉瘤等）；继发性（白血病、多发性骨髓瘤、肿瘤骨转移等）
7. 神经血管疾病	神经性关节病（Charcot 关节）、压迫性神经病变（周围神经受压、神经根受压等）、反射性交感神经营养不良等
8. 骨与软骨病变	骨质疏松、骨软化、肥大性骨关节病、弥漫性原发性骨肥厚、骨炎等
9. 关节附属器官相关病变	关节周围病变（滑囊炎、肌腱病等）、椎间盘病变、特发性下腰痛、其他疼痛综合征（如纤维肌痛综合征）等
10. 其他有关节症状的疾病	药物相关风湿综合征、慢性活动性肝炎、结节病、维生素 C 缺乏症、回纹型风湿征等

② 2

二、特点

在肺部表现为特发性肺间质纤维化

③ 3 1.系统性硬化症：**杵状指**、指端溃疡、**雷诺现象**、肺底爆裂音（指指引雷 boom）
抗核仁、抗着丝点、抗 Scl-70 抗体（硬核仁使力气）



2.炎症性肌病如皮肌炎：眶周上眼睑紫红色水肿斑、**Gottron 征**（双手关节伸面脱屑性斑丘疹）
颈部 V 形充血、技工手；**抗合成酶和 Jo-1** 抗体（JJ 微红）



④ 4 3.痛风：特殊 起病急、夜间痛、单侧第一跖趾关节（ttsx 大脚趾门）
大部分风湿系统疾病为慢性

① 理顺风湿系统疾病：
风湿性疾病是一组累积骨与关节及其周围软组织（如肌肉、肌腱、滑膜、滑囊、韧带和软骨等），以及其他相关组织和器官的慢性疾病。该类疾病包含10大类100余种疾病，其病因多种多样，发病机制不甚明了，但多数与自身免疫异常密切相关。

② 理顺表格内容：
①.弥漫性结缔组织病，直接记忆口诀："红（系统性狼疮SLE）风（类风湿关节炎）肌（炎症性肌病）干（干燥综合征）血（系统性血管炎）硬（系统性硬化症）重（重叠综合征）"。
②.血清阴性脊柱关节病，此时强调血清类风湿因子RF阴性，即"直（强直性脊柱炎）银（银屑病性关节炎）反（反应性关节炎）肠（肠病性关节炎）胃（未分化脊柱关节病）"
③.与感染相关风湿性疾病：直接记忆口诀，即"来（莱姆病）感染（与感染相关风湿性疾病）风（风湿热）批（Poncet综合征）"，口诀仅记忆。

③ 理顺系统性硬化症：
系统性硬化症SSc患者在肺部的表现就是特发性肺间质纤维化（即"硬化"），故SSC患者可有杵状指和肺底爆裂音，且因硬化导致指端缺血性溃疡，皮肤硬肿、失去弹性，且出现吞咽困难等症状，此外还有雷诺现象（本质为小动脉阵发性痉挛，故雷诺现象见于系统性硬化症、雷诺病、多发性骨髓瘤、系统性红斑狼疮等患者）。
即系统性硬化症患者为"指指引雷boom"
特异性抗体检查中，抗核仁抗体（约20～40%的SSc患者抗核仁抗体阳性）、抗着丝点抗体（是SSc的局限型CREST综合征的特异性抗体，阳性率可高达80～98%）、抗Scl-70抗体（为SSC患者血清标记抗体，与肺间质病变相关）。
即系统性硬化症患者为"硬核仁使（丝）力（0）气（7）"

④ 补充：
痛风是单钠尿酸盐沉积在关节所致的晶体性关节炎，其发病基础是嘌呤代谢中尿酸生成过多和/或尿酸排泄障碍导致的高尿酸血症。
临床前期为无症状高尿酸血症和/或尿酸盐晶体沉积，临床期表现为反复发作性急性关节炎、慢性痛风石性关节炎等。
值得注意的是在急性关节炎期间，多在午夜或清晨突然发病（因夜间代谢减弱且夜间注意力集中），关节剧痛，数小时内受累关节出现红、肿、热、痛和功能障碍，受累关节以单侧第一跖趾关节（大脚趾）最常见，但发作呈现局限性，秋水仙碱可迅速缓解症状。而慢性关节病期间可见痛风石（痛风石是痛风的特征性临床表现），典型部位在耳廓，关节周围以及鹰嘴、跟腱、髌骨滑囊等处（外观为大小不一的、隆起的黄白色赘生物，破溃后排出白色粉状或糊状物）。

急性期：秋水仙碱、NSAIDs和糖皮质激素是其一线治疗用药，应尽早使用，但注意各自药物的禁忌症。如NSAIDS于活动期消化道溃疡禁用，秋水仙碱小剂量使用效果更好（且48h内使用效果更好），糖皮质激素对并发肾功能不全患者首选，短期口服中等剂量糖皮质激素或关节腔内注射对急性关节炎有明显疗效。
慢性期以降尿酸为主，且降尿酸治疗初期预防性使用小剂量秋水仙碱3～6个月，可减少降尿酸过程中出现的痛风急性发作。此时分两类药物：
①.抑制尿酸合成药物：别嘌呤醇和非布司他（抑制黄嘌呤氧化酶活性，以减少尿酸合成）。
②.促进尿酸排泄药物：苯溴马隆抑制近端肾小管尿酸盐转运体对尿酸盐的重吸收，增加尿酸的排泄。

三、治疗

1.非甾体抗炎药 NSAIDs：其中选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）可减少胃肠道不良反应
阿司匹林COX-1抑制剂→生理性PG↓→胃溃疡

2.糖皮质激素。NSAIDs 和糖皮质激素可改善关节炎症状（改善疼痛），但**不**能控制病情 不能延缓病情发展

天天师兄

5 3.**改善病情抗风湿药 DMARDs**：
①**传统** DMARDs（起效**慢**）：甲氨蝶呤（免疫抑制剂）、柳氮磺吡啶（急淋化疗缓解期并发中枢白血病）、硫唑嘌呤、环磷酰胺（肾脏）、环孢素（难治肾综）、吗替麦考酚酯（难治肾综）、羟氯喹（抗疟药）、来氟米特、雷公藤、他克莫司（炎症性肠病）
②靶向 DMARDs（起效快）：乌帕替尼、巴瑞替尼、托法替布

4.**生物制剂/生物 DMARDs**（起效快）：单克隆抗体，如利妥昔单抗（CD20）、阿巴西普

5 理顺治疗药物：
改变病情的风湿药DMARDs才具有改善病情和延缓病情进展的作用,NSAIDs和糖皮质激素可缓解改善患者临床症状,但不能延缓病情发展。
且DMARDs药物种类众多,灵活串联前章节中学习到的药物,选择题中灵活排除NSAIDs和糖皮质激素等药物。

真题解析·风湿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N75 A 以下治疗风湿病的非甾体抗炎药物中，胃肠道不良反应最小的是
A.萘普生
B.炎痛喜康
C.塞来昔布
D.双氯酚酸

2.2015N75 A 以下选项中，符合皮肌炎特异性临床表现的是（丁丁微红）
A.上眼睑红肿
B.腮腺肿大
C.口、眼干
D.雷诺现象

3.2016N75 A 以下选项中，首发累及近端指间关节、掌指关节和腕关节的风湿性疾病是
A.类风湿关节炎
B.系统性红斑狼疮
C.强直性脊柱炎
D.骨关节炎

4.2017N56 A 下列药物属于治疗风湿病情的是
A.醋酸泼尼松
B.环孢素
C.阿司匹林
D.塞来昔布

以题带动
知识点复习

5.2020N56 A 病理和临床特点为退行性变的风湿性疾病是
A.骨关节炎
B.强直性脊柱炎

答案：1-5 C A A B A

C.银屑病关节炎
D.类风湿性关节炎

6.2023N55 A 下列风湿性疾病中，分类属于脊柱关节炎的是
A.银屑病关节炎
B.骨关节炎
C.风湿性关节炎 与乙型溶血性链球菌感染有关的变态反应性疾病
D.类风湿关节炎 弥漫性结缔组织病

7.2024N56 A 痛风性关节炎最常见的首发病变部位是
A.第一跖趾关节
B.远端指间关节 骨关节炎
C.近端指间关节 ┐类风湿
D.掌指关节 ┘

思维导图·风湿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：6-7 A A